



ACTIVIDADES OCUPACIONALES EN EL ADULTO MAYOR

Presente.

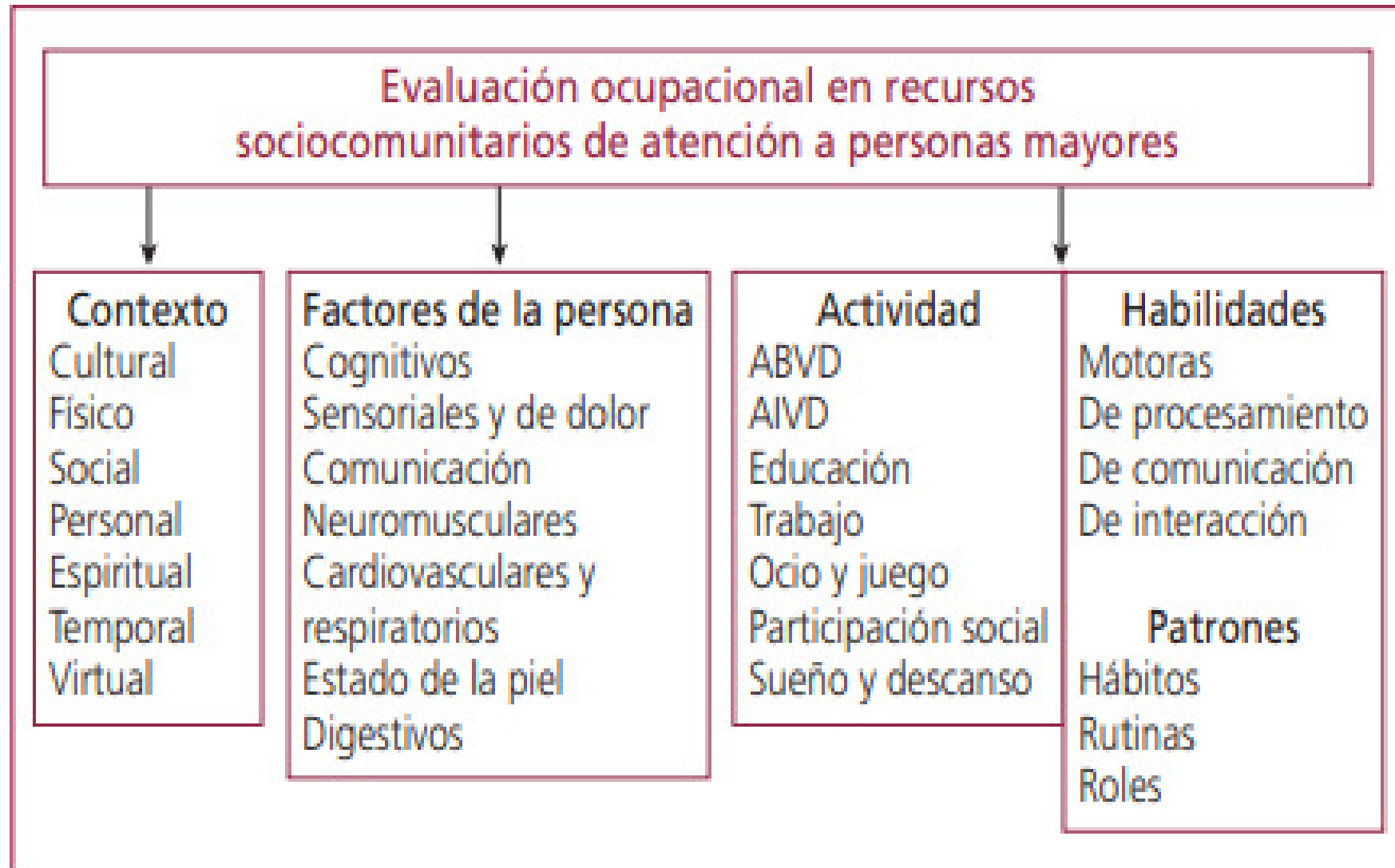
- <https://www.youtube.com/watch?v=efLcl936xDs>

¿ QUÉ ACTIVIDAD TE LLAMO LA
ATENCIÓN?
¿ QUÉ ACTIVIDAD ES MÁS FACIL?



- **PLAN GENERAL DE INTERVENCIÓN Y TERAPIA OCUPACIONAL:**
- Los centros de día y residencias de mayores cuentan con un plan general de intervención (PGI) en el que se enmarcan tanto los diferentes servicios que se desarrollan por parte de los distintos profesionales como los programas específicos de intervención.
- Este plan de intervención contempla tres áreas básicas: la persona mayor, la familia y el propio centro. La valoración e intervención integral del residente se sustenta en cuatro puntos:
 - a) Evaluación inicial interdisciplinar.
 - b) Diseño del plan individual.
 - c) Intervención y seguimiento bimensual del plan individual a través del sistema de tutorías.
 - d) Evaluación general y semestral.

- En el diseño del plan de intervención el terapeuta ocupacional participa en el establecimiento de los objetivos consensuados con el residente relativos a las capacidades necesarias para llevar a cabo aquellas actividades de la vida diaria que sean significativas e importantes para la persona.
- La intervención ocupacional en estos centros se basa en el desarrollo de distintos programas ocupacionales cuyos objetivos son la integración social, el apoyo al mantenimiento de los mayores en su medio habitual en el caso de los centros de día y la adaptación satisfactoria al nuevo hogar en el caso de las residencias de ancianos.



- Programa de actividades de la vida diaria El principal programa de intervención es el Programa de actividades de la vida diaria. Para la realización de las distintas actividades de la vida diaria, es necesario poner en funcionamiento las habilidades motoras, cognitivas y comunicativas, así como crear/mantener hábitos y rutinas que favorezcan la automatización de nuevas rutinas y movimientos a causa del deterioro funcional causado por la enfermedad.
- La actividad, en sí misma, es utilizada como fin y como medio para motivar y hacer participe al anciano en el proceso de recuperación de autonomía.

- Programa de psicoestimulación: El programa de estimulación cognitiva tiene como objetivo el mantenimiento de las funciones cognitivas necesarias para desarrollar las actividades de la vida diaria. El terapeuta ocupacional selecciona y gradúa las actividades de tratamiento en función del área cognitiva a estimular. También modifica las exigencias del entorno para que la persona alcance el éxito en la tarea. Este programa puede llevarse a cabo de forma individual o grupal.
- Las sesiones individuales permiten mayor atención por parte del terapeuta y ofrecen menos distracción al paciente para realizar las tareas cognitivas. Las actividades grupales requieren que el número de participantes no sea muy elevado (en torno a 5-8 personas) y que estas tengan un nivel cognitivo similar.



- La colaboración de un auxiliar de enfermería en estas dinámicas contribuye a un mayor seguimiento y aprovechamiento de los beneficios de la estimulación cognitiva. Las actividades que se diseñan para cada sesión tienen como objetivo estimular estas áreas de intervención y orientarlas hacia la ejecución de actividades de la vida diaria.
- Por ejemplo, puede estimularse y entrenarse la orientación espacial con el objeto de que el paciente sepa llegar a su habitación desde el control de la unidad, o encontrar el baño. Otro ejemplo sería el entrenamiento en las habilidades de secuenciación dirigidas a las prendas de vestido. Los equipos informáticos son una alternativa actual a los programas que requieren sesiones formales o material manipulativo para llevarse a cabo.



- ***Programas de intervención psicomotriz y prevención de caídas***
- El objetivo de estos programas es el de mejorar/mantener las capacidades psicomotoras necesarias para la realización de las actividades de la vida diaria y evitar caídas. Existen diferentes variantes en relación con las sesiones de psicomotricidad. Las sesiones de activación psicomotriz se desarrollan en un tiempo no superior a los 45 minutos.
- En el tiempo de iniciación se realizan ejercicios para familiarizar al participante con el contexto físico en el que se desarrolla la sesión, con los otros participantes y con el material que se utilizará. En el tiempo dedicado al núcleo central se promueven ejercicios para estimular las distintas áreas psicomotrices, como el reconocimiento corporal, la postura, el ritmo, las distancias interpersonales, etc. En la fase final de la sesión se realiza un resumen de los ejercicios realizados y de los objetivos que se han perseguido con la sesión, también se pueden incluir ejercicios de estiramiento suave.





TABLA 3. Material básico de la sala de terapia

- Ocupacional en UME
- Material audiovisual e informático
- Mesas y sillas con reposabrazos de fácil manejo
- Cama regulable en altura
- Colchonetas para actividades de relajación
- Material de rehabilitación de MMSS y MMII
- Material rehabilitación para prensión y pinza
- Material rehabilitación sensorial y sensibilidad
- Material de estimulación cognitiva
- Utensilios de baño, vestido y cocina
- Tableros de actividades instrumentales
- Soportes en pared para realizar actividades en bipedestación
- Pulsadores adaptados
- Ayudas técnicas para aseo y vestido
- Ayudas técnicas para la marcha
- Ayudas técnicas para el ocio
- Teléfonos adaptados



Presente.